

ABORDAGEM DE QUEIMADURAS



ROTINA CLÍNICA

Material bônus

INTRODUÇÃO

- As queimaduras são lesões na pele causadas por calor excessivo.
- Apresenta alguns mecanismos de lesão como descarga elétrica, calor, produtos químicos, radiação e fricção.
- A classificação das lesões térmicas é realizada de acordo com: **Área de superfície corporal total (ASCT) e profundidade.**



EXTENSÃO DA QUEIMADURA

- **Métodos de estimativa em adultos:**

Gráfico de Lund-Browder e a "Regra dos nove".

Na prática, utilizamos as duas formas, sendo o **Diagrama de Lund-Browder o mais preciso.**

A nossa sugestão é abrir a imagem no computador ou celular para fazer a análise.



ROTINA CLÍNICA

EXTENSÃO DA QUEIMADURA

- Diagrama de Lund-Browder:

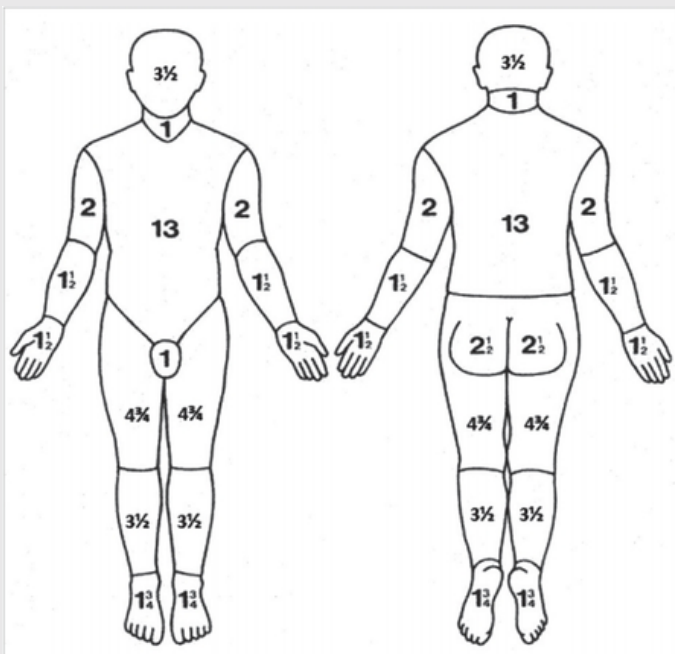


Imagem retirada de: Lund and Browder chart - Acute and Critical Care Journal.



ROTINA CLÍNICA

EXTENSÃO DA QUEIMADURA

- Regra dos nove:

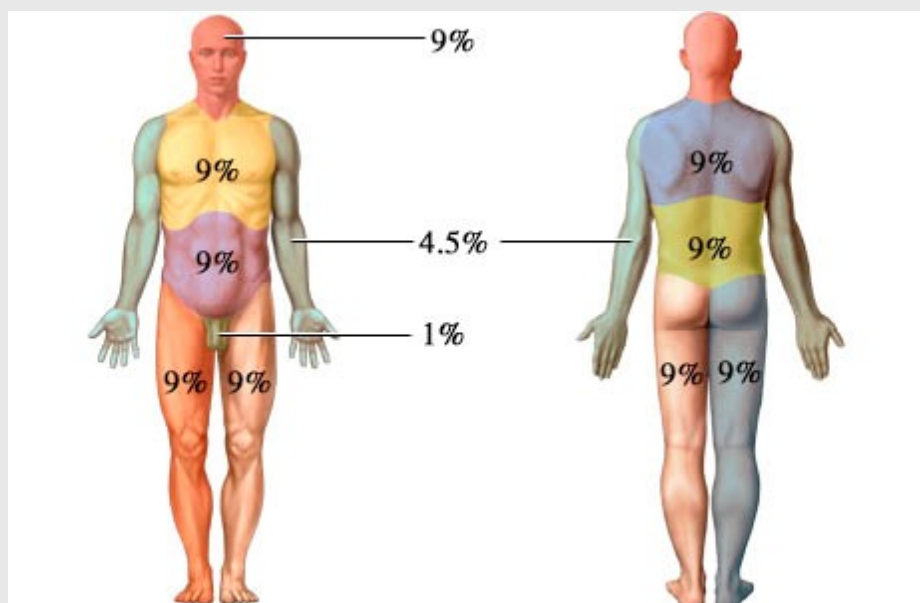


Imagem retirada de: Determining Total Body Surface Area - Minnesota Department of Health.



ROTINA CLÍNICA

PROFUNDIDADE

A profundidade é dividida em **4 níveis**:

- Superficial.
- Espessura parcial superficial.
- Espessura parcial profunda.
- Espessura total.

Pode ser difícil delimitá-las com precisão no atendimento inicial, pois podem coexistir vários níveis e poderá haver progressão entre eles. Dessa forma, o mais importante é identificar o nível mais grave e abordá-lo adequadamente.



ROTINA CLÍNICA

PROFUNDIDADE

- **1º) Superficial:**

Queimaduras superficiais envolvem **apenas** a camada epidérmica da pele.

Não formam bolhas, mas são dolorosas, secas, vermelhas e esbranquiçadas com a pressão.

Comumente, estão relacionadas a queimaduras solares.

Tendem à cicatrização completa em 6 dias sem deixar cicatrizes.



PROFUNDIDADE

- **2º) Espessura parcial superficial:**

Formam-se **bolhas** dentro de 24 horas entre a epiderme e a **derme**.

São lesões tipicamente dolorosas ao ar, temperatura e ao toque; vermelhas, lacrimejantes e empalidecem com a pressão.

Cicatrizam entre 7 e 21 dias.



ROTINA CLÍNICA

PROFUNDIDADE

- 3º) Espessura parcial profunda:

Estende-se até a **derme mais profunda** e é caracteristicamente diferente das queimaduras de espessura parcial superficial.

Bolhas (facilmente destacáveis); molhado ou ceroso seco, com cor variável (irregular de queijo branco a vermelho) e o branqueamento com pressão pode ser lento.

Via de regra, requer tratamento cirúrgico.



ROTINA CLÍNICA

PROFUNDIDADE

- **4º) Espessura total ou completa:**

Estendem-se e destroem **todas** as camadas da derme e, frequentemente, ferem o tecido subcutâneo subjacente.

Geralmente anestésicas ou hipoestésicas. A aparência da pele pode variar de branco ceroso a cinza coriáceo a carbonizado e preto.



ABORDAGEM

- **1º) Superficial:**

Não se calcula a superfície corporal acometida.

Pode-se aplicar compressas ou imersões com água em temperatura ambiente.

Não se deve aplicar gelo.

A analgesia pode ser realizada com analgésico comum e AINEs.

Sugestão:

- Ibuprofeno 600 mg de 8/8 horas.
- Dipirona 1 grama de 6/6 horas como adjuvante.



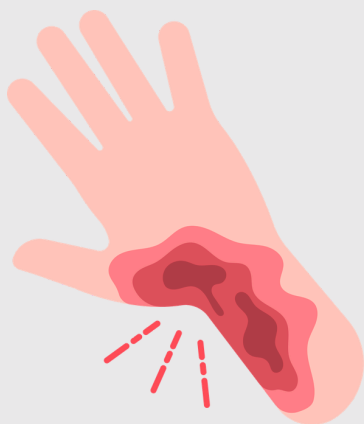
ROTINA CLÍNICA

ABORDAGEM

Critérios de encaminhamento para o Centro de Queimados (CTQ):

Queimaduras de espessura parcial maiores que 10%.

Queimaduras que envolvem a face, mãos, pés, genitália, períneo ou grandes articulações.



ROTINA CLÍNICA

ABORDAGEM

2º) Parcial superficial:

Sem critérios de transferência para hospital de referência:

Analgesia

Ibuprofeno 600 mg de 8/8 horas.

Dipirona 1 grama de 6/6 horas como adjuvante.

Codeína 30 mg de 4/4 horas em caso de dor forte.



ABORDAGEM

3º) Parcial profunda:

Sem critérios de transferência para hospital de referência:

Retirar roupa acometida, joias e anéis.
(CHAMAR ACOMPANHANTE).

As áreas queimadas devem ser resfriadas imediatamente com água fria (12°C) ou gaze embebida em solução salina, por 15 a 30 minutos.

Realizar curativo compressivo com Sulfadiazina de prata, evitando o rosto.



ROTINA CLÍNICA

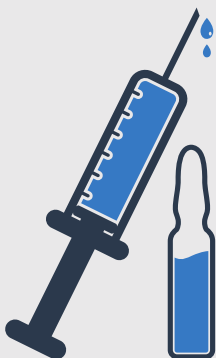
ABORDAGEM

3º) Parcial profunda:

Analgesia adequada, lançando mão de opioide endovenoso.

Morfina EV: Diluir 1 ampola de 10 mg em 10 ml de SF 0,9%. Administrar 1 ml a cada 10 kg de peso corporal.

Encaminhar o paciente para a **emergência** e entrar em contato com o **SAMU** para transferência para o CTQ.



ROTINA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

- Avaliação e classificação de queimaduras – UpToDate.
- Atendimento de emergência de queimaduras térmicas moderadas e graves em adultos – UpToDate.
- Tratamento de pequenas queimaduras térmicas – UpToDate.

